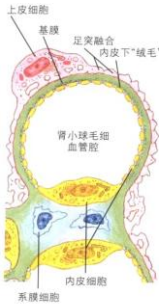
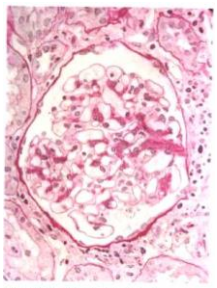
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿、高血脂症

（2）**典型肾病综合征：几乎无血尿、高血压**。但脂性肾病在 60 岁后发病率又呈小高峰，其高血压、肾功能损害多见



电镜改变：仅见上皮细胞足突融合和一些内皮细胞下"绒毛"



光镜改变：肾小球正常：肾小管管腔内可有蛋白沉积，小管上皮细胞内有脂滴(PAS, ×250)

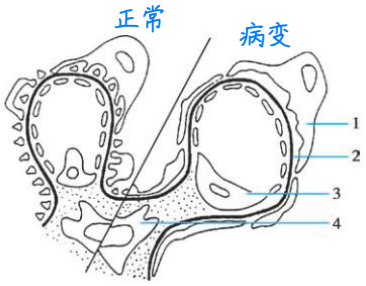


图 5-2-5　微小病变型肾病示意图

左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞足突消失；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞。

-都有血尿　-可有血尿　-几乎无血尿　　肾病综合征与有血尿不矛盾

注意：急性肾炎、急进性肾炎、慢性肾炎、脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化

抓规律：多数原发性肾小球疾病	记特殊：脂性肾病
与体液免疫有关	与 T 细胞异常的细胞免疫有关
机械和电荷屏障受损　机械屏障受损就会有血尿	只有电荷屏障受损 光镜下肾小球正常
可为选择性、非选择性蛋白尿	仅为选择性蛋白尿 尿中只有白蛋白
可有血尿（其中名字里带"炎"的几乎有血尿）	几乎无血尿（典型肾病综合征）
可有高血压 急性肾炎综合征常见	几乎无高血压（典型肾病综合征）

病变累及系膜区，有很多WBC参与，叫炎；当病变累及系膜区时，系膜细胞增生，拉肾小球毛细血管袢，将基底膜拉断

抓规律：原发性肾小球疾病	记特殊
均有**玻璃样变性/透明变性** 近端小管重吸收蛋白尿中蛋白质	脂性肾病：还有**脂肪变性**　高风亮节喂狼超糖 急进性肾炎、重症急性肾炎：还可有**纤维素样坏死**（又急又重）
多数为**颗粒状荧光**	①**线状荧光：I型急进性肾炎**（继发者：**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征）　抗体和到基底膜固有抗原上成一条线 ②**没有荧光：脂性肾病、III型急进性肾炎**（继发者：**显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿**）　细胞免疫　自身抗体ANCA
多数有**电子致密物**	**没有电子致密物：脂性肾病、III型急进性肾炎、I型急进性肾炎→电镜下分不出**　急进性肾炎中只有I工型急进性肾炎有电子致密物
IgA 肾病可为各种病理类型（ttsx 解题时勿忘记）	

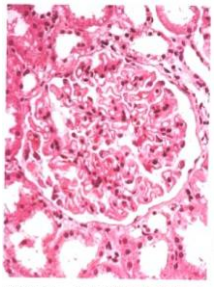
细胞内的玻璃样变性：①玻璃样小体②Mallory小体③Russell小体

2.**膜性肾病**（中老年历经磨难吃鸡丁）　膜性肾病：嘿摸脚-原位免疫复合物

①**基膜明显增厚**（毛细血管壁明显增厚），早期仅于肾小球基底膜上皮侧见少量散在分布的嗜复红小颗粒，进而有**钉状突起**、齿梳样、虫蚀样空隙，可有脏层足细胞**足突融合消失**　基底膜

②**中老年最常见的肾病综合征**；最易发生**肾静脉**血栓并发症

③抗磷脂酶 A_2 受体特异性抗体 PLA_2R 可协助诊断、疗效、监测复发　VS 脂性肾病也有足突融合消失



光镜改变：基膜增厚，嗜酸性；上皮细胞、内皮细胞和系膜细胞明显但数目不增多(HE, ×250)



电镜改变：上皮细胞下有电子致密沉积物，基膜增厚，足突融合

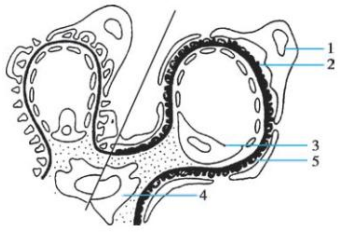


图 5-2-8　膜性肾病示意图

左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物。

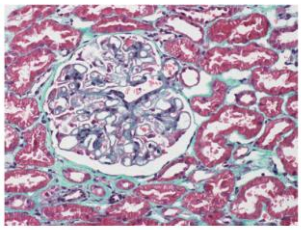


图 13-16　膜性肾小球病

示肾小球基膜增厚(Masson 染色，400 倍)。

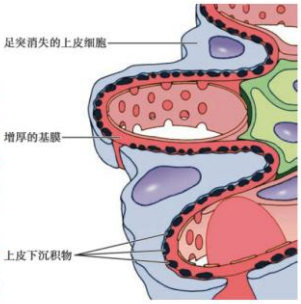


图 13-17　膜性肾小球病示意图